

2025년 경상남도교육청 학교 감염병 예방 세부 대책

2025. 2.



경상남도교육청

<http://www.gne.go.kr>

【체육예술건강과】

목 차

I. 근거 및 추진배경	1
1. 근거	1
2. 추진배경	1
II. 현황 및 실태	2
1. 현황	2
2. 실태	4
III. 세부 추진과제	5
1. 학생 감염 감시 강화 및 예방 환경 조성	6
1-1. 감염병 감시 정보 공유 및 NEIS 체계 보완	
1-2. 학교 예방 교육 및 홍보 강화	
1-3. 신입생 예방접종을 제고	
2. 학교 내 확산 시 대응체계 보완	11
2-1. 학교 감염병 대응 역량 강화	
2-2. 학교 필수 방역물품 확보	
3. 방역 인프라 확충 및 제도 개선	13
3-1. 유관기관과의 협력체계 강화	
IV. 추진 체계	14
V. 부록 - 제출 현황 및 참고 자료	15
VI. 주요 변경사항	17

I. 근거 및 추진배경

1 근거

- 학교보건법 제14조의3(감염병예방대책의 마련 등)
- 교육부 학생건강정책과-8212(2023.12.26.)호 “제2차 「학교 감염병 예방 종합대책」 수립 안내”
- 체육예술건강과-7174(2024. 6. 3., “제2차 「학교 감염병 예방 세부대책 (2024~2028)」수립 및 2024년 보고사항 안내”)

2 추진 배경

- 학령기 빈발 감염병의 재출현*, 해외교류 증가로 특성이 알려지지 않은 신종 감염병의 국내 유입 및 확산** 등에 대한 선제적 대비 필요
 - * 4종(인플루엔자, 수두, 수족구, 유행성이하선염) 감염병이 주기적 반복 유행
 - ** 【팬데믹 사례】 신종인플루엔자A(H1N1) ('08~'09년), MERS('15년 4월~11월), COVID-19('20년 1월 ~'24 현재) / 신종호흡기 감염병 대유행 및 인명피해 초래
- 특히 신종감염병은 “감염경로·예방 정보, 백신 및 치료제”가 미비하여 학교 등 교육기관 내 유입 시 학생 피해 및 지역사회 확산 우려
 - ※ 교육기관 내 확산은 학생 건강 및 학사운영 차질, 가정 및 지역사회 유행과 직결
- 따라서, 감염병 예방을 위한 생활 속 실천수칙 교육, 예방접종력 관리와 함께 코로나19 팬데믹 경험을 토대로 교육기관 방역체계 보완 필요
 - 유행 감시 체계 보강, 학교·교육청의 유사 시 대응 및 협력체계 보완, 방역 물품 비축 등 방역 모델 개발, 대응 매뉴얼 등 정비
- 경남형 학교 감염병 예방 세부대책 수립으로 실효성 확보
 - 경남 단위에서 실천 가능한 세부대책을 수립함으로써 궁극적으로 학생과 교직원을 감염병으로부터 보호하고 안전한 교육환경 조성

II. 현황 및 실태

1 현 황

학교 내 감염병 발생 현황(NEIS기준)

- 22년~23년까지 학생 감염병 발생건수는 증가하였으나, 2024년 인플루엔자 발생률이 떨어져 감염병 발생건수가 감소한 것으로 나타남
 - 2023년 코로나19 방역수칙 완화에 따라 감염병 발생건수 증가(추측)
 - 연도별 발생건수: 24,319명(2022년) → 62,610명(2023년) → 27,117명(2024년)

● 최근 3년간 주요 감염병 발생 현황 (25.1.21.NEIS 기준)

구분	인플루엔자	유행성 이하선염	수두	백일해	수족구병	유행성 각결막염	결핵	기타	총 감염병 발생건수
2022년	21,283 (87.5%)	82 (0.3%)	505 (2.1%)	0 (0%)	244 (1%)	116 (0.5%)	5 (0%)	2,084 (8.6%)	24,319
2023년	44,248 (70.7%)	122 (0.2%)	811 (1.3%)	134 (0.2%)	759 (1.2%)	260 (0.4%)	2 (0%)	16,274 (26%)	62,610
2024년	10,659 (39.3%)	105 (0.4%)	1,110 (4.1%)	3,120 (11.5%)	1,407 (5.2%)	97 (0.4%)	1 (0%)	10,618 (39.2%)	27,117

- 백일해, 수두, 수족구병이 23년 대비 24년 증가한 것으로 나타남

● 2024년 학교 급별 주요 감염병 발생 현황 (단위: 명)

구분	인플루엔자	유행성 이하선염	수두	백일해	수족구병	유행성 각결막염	결핵	기타	총 감염병 발생건수
초	5,729	81	755	1,681	1,347	66	0	4,853	14,512
중	3,538	12	272	840	40	17	1	2,620	7,340
고	1,358	12	80	580	11	14	0	3,115	5,170
특수	34	0	3	19	9	0	0	30	95

- 인플루엔자(39%) · 기타(39%)* > 백일해(12%) > 수족구병(5%) > 수두(4%) 등 순으로 발생

* 기타: 코로나19, 급성호흡기감염증 등 포함

● 지역별 발생현황

지역	창원	진주	통영	사천	김해	밀양	거제	양산	의령
발생건수	9,297	2,197	1,985	809	4,923	433	2,437	2,085	90
학생수(명)	108,922	38,716	13,557	11,371	66,125	8,355	33,287	43,093	1,409
발생률(%)	8.5%	5.7%	14.6%	7.1%	7.4%	5.2%	7.3%	4.8%	6.4%
지역	함안	창녕	고성	남해	하동	산청	함양	거창	합천
발생건수	691	347	391	410	144	49	243	288	298
학생수(명)	5,694	4,709	4,193	3,166	2,251	1,976	2,569	6,231	2,107
발생률(%)	12.1%	7.4%	9.3%	13.0%	6.4%	2.5%	9.5%	4.6%	14.1%



- 발생건수는 창원(9,297) > 김해(4,923) > 거제(2,437) > 진주(2,197) 순
- 학생수 대비 발생률은 통영(14.6%) > 합천(14.1%) > 남해(13%) > 함안(12.1%) 순

2 실 태

개인 위생수칙(손씻기, 기침예절 등) 교육 강화 필요

● 연간 개인위생 교육 경험률(중·고등학교)

2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	비고
38.8%	68.5%	52.5%	40.5%	43.3%	43%	

- 코로나19 발생 이전보다는 개인위생 교육 경험률이 높으나, 지속적으로 감소하는 추세
- 중·고등학교에는 감염병에 대한 위생교육 필요

● 식사 전 비누이용 손씻기 실천율(중·고등학교)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	비고
학교	52.1%	62.3%	53.9%	52.4%	45.6%	45.5%	
가정	68.2%	68.9%	68%	64.1%	62.5%	62.1%	

- 개인위생 교육 경험률이 떨어짐에 따라 식사 전 비누이용 손씻기 실천율도 동반 하락

※출처-청소년건강행태온라인조사 자료

감염병 예방을 위한 ‘학교-가정’ 홍보 강화 필요

● 개인수칙 실천율이 떨어지고 있어, 학교-가정에 감염병 예방을 위한 예방수칙 홍보 필요

- ※ 도내 학교 감염병 주간 발생 현황을 공문게시를 통해 안내하고 있어, 매주 도내 감염병 발생현황을 확인하여 선제적 교육 필요

● 다문화 학생이 많은 학교에서는 분기별 5개 국어 감염병 관련 홍보자료를 바탕으로 홍보 활동 강화

- ※ 분기별 학생감염병 소식지 공문게시를 통해 5개 국어 자료 배포

감염병 예방 관련 교육 실시 필요

● 감염병 발생시 다양한 구성원이 참여해야 하는 상황을 고려하여, 관리자·보건(담당)교사에 맞는 맞춤형 교육 필요

● 감염병 위기상황에 효과적으로 대응하기 위한 평시 전 공무원에 대한 감염병 교육·훈련 체계 구축

- ※ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제18조의 5항 및 동법 시행령 제17조

III. 세부 추진과제

목표

감염병 위협으로부터 **안심**할 수 있는 **학교방역체계 유지**

전략

평상시 학교 내
유입차단 체계 강화



위기상황 발생 시
안정적 · 선제적 대비

추진 과제

①
학생 감염
감시 강화 및
예방 환경 조성

① 감염병 감시 정보 공유 및 NEIS 체계 보완

② 학교 예방교육 및 홍보 강화

③ 신입생 예방접종을 제고

②
학교 내 확산 시
대응체계
보완

① 학교 감염병 대응 역량 강화

② 학교 필수 방역물품 확보

③
방역 인프라
확충 및
제도 개선

① 유관기관과의 협력체계 강화

1 ▶ 학생 감염 감시 강화 및 예방 환경 조성

1-1 감염병 감시 정보 공유 및 NEIS 체계 보완

가 추진 현황

- (학교) 감염병 예방·관리 연간 계획 수립
 - 효율적인 감염병 대응을 위한 학교 감염병 관리 조직 구성
 - 초·중학교 입학생 필수예방접종 관리
 - 감염병 예방 교육
 - 학교 내 감염병 발생 시 보고 및 대응
 - 수동감시체계 운영
 - 일시적 관찰실 지정
 - 방역 활동
- (교육지원청) 지역 유행 감시체계 구축과 운영
 - 감시체제 시스템 구축·강화[나이스(NEIS)를 통한 지역 내 감염병 발생 감시]
 - 감염병 관리 체계 구축(전문인력 배치, 정보제공, 모의훈련, 감염병관리협의체 등)
- (교육청) 감염병 유행 감시체계 구축 및 운영, 감염병 예방·관리 연간 계획 수립
 - 지역별 감염병 발생 유행 감시체계 구축
 - 학교 내 감염병 발생 시 학교유행경보제 운영 검토
 - 도청 및 감염병관리지원단 등 감염병 관리 체계 구축

나 사업 목표

- 교육(지원)청 및 전 학교 감염병 관리 대응반 구성 및 운영으로 감염병 확산 방지
- 유관기관과 상시 협조체계 유지, 감염병 발생에 따른 신속한 대응 및 조치
- 효율적 업무 분장을 통한 체계적 관리로 감염병 조기 확산 방지

다 주요 내용

- [교육청] 경남 학생 감염병 발생현황 주간별 분석 및 정보 제공
 - 감염병 주간 발생 현황 및 시기별 빈발 감염병에 대한 유행 정보 안내

- 학교 및 교육(지원)청별 대응반 구성
 - [학교] 감염병 관리 담당자뿐만 아니라 학교내 다양한 구성원으로 구성
 - [교육(지원)청] 교육(지원)청 및 지역 내 보건당국 등 유관기관 관계자로 구성하여 전문적인 협력체계 구축
 - 감염병 예방 및 확산방지를 위해 구성원간 역할분담을 명확히 하여, 위기 상황 발생시 명확하고 신속한 대응
 - 『학교 감염병 예방·위기 대응 매뉴얼 제3차 개정판』 참고하여 구성 및 운영
- 감염병 관리 대응반 협의를 통한 보완 사항 점검
 - [학교]: 감염병 확진자 다수 발생 또는 자체 판단에 따라 구성원간 감염병 관련 소통
 - [교육(지원)청]: 연 1회 이상 지역내 감염병 발생 관련 협의회 실시
 - [교육청]: 연 1회 이상 도내 감염병 발생 관련 협의회 실시
- NEIS 기능 개선 및 보완
 - [교육부]: 법정감염병 분류체계 변경 등을 반영하여 NEIS 관리 기능 개선 및 지속 보완

라

행정 사항

세부과제	활동	내용	제출대상	제출시기
학생 감염병 관리 대응반 구성 및 운영	협의체 구성 및 운영	감염병 관리 대응반 구성 현황	학교 및 교육(지원)청	매년 12월 [서식1]
학생 감염병 관리 대응 협의회	감염병 발생 대응 관련 협의회 실시하여 대응방안 모색	협의회 실시 현황	교육(지원)청	매년 12월 [서식1]

1-2

학교 예방교육 및 홍보 강화

가

추진 현황

- 「학교보건법」 및 초·중등학교 교육과정에 따른 체계적인 보건교육 운영
 - 학년 단위 17차시 이상 보건교육 실시 학교: 경남 초중고 984교 중 865교(87.9%)
- 학교 교육과정 편성 시 보건 선택과목 운영 현황

【 2024년 중·고등학교 보건과목 선택 현황(단위: 교) 】

구 분	중학교(특수학교 포함)		고등학교(특수학교 포함)		계	
	전체	선택	전체	선택	전체	선택
경남	280	123	208	112	488	235

※ 전체 학교수: 보건교사 배치교 및 미배치교 모두 포함

- 보건소식지, 가정통신문 등을 활용하여 학부모에게 감염병 홍보 및 자료제공

나

사업 목표

- 체계적인 보건교육을 통해 학생들이 최적의 건강 상태를 유지하고 이를 증진시킬 수 있는 자기건강관리 능력 함양
- 학교 보건교육 내실화를 위한 교사연수, 보건교사 보조인력배치 등 지원활동 강화
- 보건교육 역량 강화, 수업 전문성 향상 연수 운영, 수업나눔 및 컨설팅 활동, 보건교과 연구회 등을 통한 보건교육 활성화 도모
- 학부모에게 감염병에 대한 자료를 제공함으로써 감염병 의식 제고하고, 의심 증상시 학교 등교 및 학원 등교 중지 등 교육

다

주요 내용

- [학교]
 - 학교 교육계획 수립 시 실질적인 교육내용, 방법, 시수, 대상 등을 고려하여 체계적인 보건교육이 가능하도록 학교 교육과정 편성·운영
 - 학교 내 감염병 예방 강화를 위한 최소 교육 이수시간*(연간 4시간 이상) 마

련 및 교육효과 제고를 위한 교육방법 다양화

※ 학교보건법, 아동복지법*에 따라 유치원 및 초·중등학생 대상 교육 실시 의무

* 감염병 및 약물의 오용·남용 예방 등 보건위생관리 교육 실시 의무화(연간10시간)

○ [교육청] 체계적인 보건교육이 실시될 수 있도록 행·재정적 지원 강화

- 보건지원강사 지원: 36학급(초·중등)이상 보건교사 2인 미배치교, 당뇨병 및 희귀난치성 질환 등 건강장애학생 재학교, 보건선택교과 학교 등
- 예산: 1,469,000천원 편성, 113교
- 매년 3월부터 학교 수요조사를 통해 예산 지원(36주)

라

행정 사항

세부과제	활동	내용	제출대상	제출시기
학년 단위 17차시 이상 보건교육 실시	교육과정 중 개인위생수칙 및 감염병 특징 등 교육	17차시 이상 보건교육 편성 여부	학교	학생건강증진 시행계획 참고
학교 예방 교육 홍보를 위한 경남 감염병 발생 현황 및 홍보자료 배포	감염병 발생에 따른 예방수칙 등 홍보자료 배포	홍보자료 배포 실적	도교육청	수시

1-3

신입생 예방접종을 제고

가

추진 현황

- 질병관리청 및 교육부 시스템 연계를 통하여 초·중학교 입학생 대상 예방접종력 확인 사업 실시

나

사업 목표

- 적기에 예방접종을 실시하여 예방접종 대상 감염병의 학교 내 확산 방지
- 예방접종을 통한 학교 내 감염병 인식 제고
- 예방접종력 확인 사업 종료 전 예방접종 관련 NEIS 기록 누락, NEIS 반영, 입력 착오 등의 사항이 없는지 확인
- 다문화 가정을 위한 다국어(12개 외국어) 안내 접종 홍보자료를 제공하여 다문화 학생 예방접종을 제고
- 유치원 학생에 대한 국가필수예방접종력 확인을 통해 유치원 감염병 발생 방지

다

주요 내용

- [학교] 시스템 연계 후 NEIS에 해당 자료 반영을 통해 예방접종 확인 철저, 예방접종 미실시 학생에 대하여 접종을 받을 수 있도록(접종금기자 제외) 학부모 안내, 특정 감염병 유행 시 방역당국의 결정에 따라 예방접종 강조 안내
- [교육지원청] 관내 학교 NEIS 자료 추출 현황 파악하여 안내 및 독려, 특정 감염병 유행 시 방역당국의 결정에 따라 각급학교에 예방접종 강조 안내

	현 행	개 선
중 학교 입 학생	Tdap(또는 Td) 6차 일본뇌염(불활성화 백신 5차 또는 약독화 생백신 2차) HPV 1차(여학생만 대상)	좌동
초 등 학 교 입 학생	DTaP 5차, IPV 4차, MMR 2차, 일본뇌염(불활성화백신 5차 또는 약독화 생백신 2차)	좌동
유치원 입 학생	미 시행	DTaP(5차), IPV(4차), MMR(2차), 일본뇌염

※ 백신종류에 따른 대상감염병은 V. 부록(참고자료) 참고

2 학교 내 확산 시 대응체계 보완

2-1 학교 감염병 대응 역량 강화

가 추진 현황

- 학교관리자, 보건·담당교사 대상 온/오프라인 연수('24~)
 - 감염병 법령의 이해, 발생 시 대응방안, 위기상황 시 보건소·교육청 등과의 연계 협력방안 등 집중 교육

나 사업 목표

- 감염병 교육 실시를 통해 학교 관계자 및 교육지원청 감염병 의료 역량강화 실시

다 주요 내용

- [학교] 감염병 관리역량 강화를 위한 연수과정 운영 및 학교자체 모의훈련 실시
 - 학교관리자 및 담당 교원 대상, 교육(지원)청 담당자 대상 연수과정 운영
- [교육지원청] 감염병 모의훈련시 다양한 구성원이 참여하는 연수를 실시하고, 감염병 전문가 초빙을 통한 의료역량 강화
- [전 기관] 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」제18조의 5항 및 동법 시행령 제17조에 따라 도교육청 및 직속기관, 교육지원청 및 소속기관, 학교 감염병 교육 이수

라 행정 사항

세부과제	활동	내용	제출대상	제출시기
감염병 위기대응 모의훈련 실시율	감염병 위기대응 모의훈련 실시	학교별 모의훈련 실시 현황	학교 및 교육지원청	매년 12월
모의훈련 연수시 감염병 전문성 향상을 위한 대응책 마련	관리자, 보건(담당)교사 대상 연수시 감염병 역량강화 위한 강의	보건(담당)교사 대상 감염병 전문성 향상 강의 실시 여부	교육(지원)청	매년 12월
전 교직원 감염병 관련 교육실시	중앙교육연수원에 탑재된 감염병 관련 연수 실시	전 교직원 이수율	교육(지원)청 직속 및 소속기관, 학교	매년 12월

2-2

학교 필수 방역물품 확보

가

추진 현황

- 평상시 및 위기상황 구분하여 비축 모형 안내
- 학교 방역물품 활용실태 분석을 통한 적정 비축기준 마련

나

사업 목표

- 2024년 기준 학교 방역물품 비축 권장 모형에 따라 방역물품 비축완료
- 체계적인 방역물품 관리체계 구축을 통해 위기상황시 대응력 제고

다

주요 내용

- [학교] 학교 내 방역모형 보급 및 방역물품 확보
 - 평상시 및 위기상황을 대비하여 필수 방역물품을 추가 확보할 수 있도록 학교회계 예산 편성

【 학교 방역물품 비축 권장 모형(현행) 】

비축 목적	방역 물품	비축 우선순위	비축 기준	
			비축 장소	비축 물량
발열 감시	고막 체온계	높음	교실	교실당 1개
			보건실	1개
	비접촉체온계		교실	교실당 1개
			보건실	1개
장갑	의료용 장갑	높음	교실	교실당 5개
마스크	보건마스크 (KF80 이상)	높음	교실	교실당 20개
			보건실	학생 10명당 3개
	수술용		교실	교실당 20개
			보건실	학생 10명당 3개
손 소독	알코올 손 소독제	높음	교실	교실당 4개
			보건실	8개
환경 소독	락스	높음	보건실	2개
	살균 티슈		보건실	보건실 운영일 × 소독필요 물품 수

라

행정 사항

세부과제	활동	내용	제출대상	제출시기
학교 내 방역 물품 확보	방역 물품 구입 및 비치	학교 내 방역 물품 현황	학교	매년 7월

3 방역 인프라 확충 및 제도 개선

3-1 유관기관과의 협력체계 강화

가 추진 현황

- 감염병 발생시 원활한 대응을 위한 유관기관 및 전문가 협력 체계 구축
- 감염병 발생시 임의적인 유관기관 및 전문가 협의회가 아닌 정기적인 협의체 구성

나 사업 목표

- 유관기관 및 전문가 협력 체계를 구축하여 반기별 1회 감염병 발생 현황 및 대응 관련 협의회 실시
- 감염병 상황 공유·감염병 발생시 대응 방안 모색 및 협력 강화

다 주요 내용

- 교육(지원)청별 보건소, 학교 관계자, 의사 등 전문가 협력체계를 구축하고 이에 따른 비상연락망 구축

라 행정 사항

세부과제	활동	내용	제출대상	제출시기
교육(지원)청 및 유관기관 비상연락망 구축	감염병 발생시 신속한 대응을 위한 비상연락망 구축	비상연락망 구축 여부	교육(지원)청	자체 계획

IV. 추진 체계

1 추진 체계

● 기획팀

연번	소속	성명	직위 및 직급	비고
1	도교육청 체육예술건강과	최인용	과장	당연직
2	도교육청 체육예술건강과	유미영	보건담당	
3	도교육청 체육예술건강과	최은영	장학사	
4	도교육청 체육예술건강과	손연정	주무관	
5	도교육청 체육예술건강과	권대혁	주무관	

● 감염병관리협의체

연번	소속	성명	직위 및 직급	담당역할
1	경상남도교육청	최인용	최인용	총괄
2	경상남도교육청	유미영	보건담당	세부대책 추진
3	경상남도교육청	최은영	장학사	보건교육
4	경상남도청	강은영	감염병예방파트장	감염병 관리 사업 추진
5	감염병관리지원단	황혜진	부단장	감염병 담당 (역학조사, 대응훈련 등)
6	감염병관리지원단	신솔희	책임연구원	감염병 담당 (역학조사, 대응훈련 등)
7	창원파티마병원	마상혁	과장	자문
8	국립경상대병원	서지현	교수	자문
9	진주교육지원청	서지혜	보건급식담당 팀장	세부대책 추진 관련 교육지원청 업무 지원
10	대방초등학교	장종욱	교장	학교 현장의견 반영
11	구산고등학교	김선란	행정실장	학교 현장의견 반영
12	창원상남중학교	송은혜	보건교사	학교 현장의견 반영

V. 제출 현황 및 참고 자료

제출 현황

연번	내용	제출대상	제출기한	서식	비고
1	학생 감염병 관리 대응반 구성 및 운영	학교→교육지원청 교육지원청→도교육청	·25.12.05.(금) ·25.12.12.(금)	서식1	
2	학생 감염병 관리 대응 협의회	교육지원청→교육청	·25.12.12.(금)	서식4	
3	감염병 위기대응 모의훈련 실시	학교→교육지원청 교육지원청→도교육청	·25.12.05.(금) ·25.12.12.(금)	서식2	
4	모의훈련 연수시 의료 전문성 향상을 위한 대응책 마련	교육지원청→교육청	·25.12.12.(금)	서식5	
5	전 교직원 감염병 관련 교육실시	학교→교육지원청 교육지원청→도교육청	·25.12.19.(금) ·25.12.24.(수)	별도 서식	
6	학교 내 방역물품 확보현황	학교→교육지원청 교육지원청→도교육청	·25.07.11.(금) ·25.07.18.(금)	서식3	
7	교육(지원)청 및 유관기관 비상연락망 구축	자체계획			

[참고자료]

표준예방접종일정표

출처: 질병관리청 「2024 표준예방접종 일정표」

대상전염병	백신종류	횟수	출생 시	4주 이내	1개월	2개월	4개월	6개월	12개월	15개월	18개월	19~23개월	24~35개월	4세	6세	11세	12세
B형간염	HepB ¹⁾	3	1차		2차			3차									
결핵	BCG(파내용) ²⁾	1		1회													
디프테리아 파상풍 백일해	DTaP ³⁾	5				1차	2차	3차		4차				5차			
	Tdap/Td ⁴⁾	1														6차	
폴리오	IPV ⁵⁾	4				1차	2차	3차						4차			
b형헤모필루스 인플루엔자	Hib ⁶⁾	4				1차	2차	3차	4차								
폐렴구균	PCV ⁷⁾	4				1차	2차	3차	4차								
	PPSV ⁸⁾	-												고위험군에 한하여 접종			
로타바이러스 감염증	RV1 ⁹⁾	2				1차	2차										
	RV5 ¹⁰⁾	3				1차	2차	3차									
홍역 유행성이하선염 풍진	MMR ¹¹⁾	2							1차					2차			
수두	VAR ¹²⁾	1							1차								
A형간염	HepA ¹³⁾	2							1~2차								
일본뇌염	IJEV ¹⁴⁾	5							1~2차			3차		4차		5차	
	LJEV ¹⁵⁾	2							1차			2차					
사람유두종바이러스 감염증	HPV ¹⁶⁾	2														1~2차	
인플루엔자	IIV ¹⁷⁾	-							매년접종								

● 국가예방접종: 국가에서 권장하는 필수예방접종(국가는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」을 통해 예방접종 대상 감염병과 예방접종 실시기준 및 방법을 정하고, 이를 근거로 재원을 마련하여 지원하고 있음)

- 1) HepB(B형간염): B형간염 표면항원(HBsAg) 양성인 산모로부터 출생한 신생아는 분만 직후 12시간 이내 B형간염 면역글로불린(HBIG) 및 B형간염 백신(1차)을 동시에 접종하고, 2차와 3차 접종은 각각 생후 1개월 및 6개월에 실시
- 2) BCG(결핵): 생후 4주 이내 접종
- 3) DTaP(디프테리아·파상풍·백일해): DTaP-IPV(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오) 또는 DTaP-IPV/Hib(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오·b형헤모필루스인플루엔자) 혼합백신으로 접종 가능
- 4) Tdap/Td(파상풍·디프테리아·백일해·파상풍·디프테리아): 11~12세 접종은 Tdap 또는 Td 백신으로 접종 가능하나, Tdap 백신을 우선 고려
※ 이후 10년마다 Tdap 또는 Td 추가접종(11세 이후 접종 중 한 번은 Tdap으로 접종)
- 5) IPV(폴리오): 3차 접종은 생후 6개월부터 18개월까지 접종 가능하며, DTaP-IPV(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오) 또는 DTaP-IPV/Hib(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오·b형헤모필루스인플루엔자) 혼합백신으로 접종 가능
- 6) Hib(b형헤모필루스인플루엔자): 생후 2개월 ~ 5세 미만 모든 소아를 대상으로 접종하며, 5세 이상은 b형헤모필루스인플루엔자 감염 위험성이 높은 경우(기능적 또는 해부학적 무비증(결상적혈구증, 비장 절제술 후), 면역결핍질환(특히 IgG2 아형 결핍증), 항암치료에 따른 면역저하, HIV 감염, 초기 요소 보체결핍증, 조혈모세포이식술을 받은 경우) 접종, DTaP-IPV/Hib(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오·b형헤모필루스인플루엔자) 혼합백신으로 접종 가능

- DTaP-IPV(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오) 혼합백신: 생후 2, 4, 6개월, 4~6세에 DTaP, IPV 백신 대신 접종할 수 있음
- DTaP-IPV/Hib(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오·b형헤모필루스인플루엔자) 혼합백신: 생후 2, 4, 6개월에 DTaP, IPV, Hib 백신 대신 접종할 수 있음
※ DTaP 혼합백신 사용 시 기초접종 3회는 동일 제조사의 백신으로 접종하는 것이 원칙이며, 생후 15~18개월에 접종하는 DTaP 백신은 제조사에 관계없이 선택하여 접종 가능

- 7) PCV(폐렴구균 단백결합): 10가와 13가 단백결합 백신 간에 교차접종은 권장하지 않음
- 8) PPSV(폐렴구균 다당질): 2세 이상의 폐렴구균 감염의 고위험군을 대상으로 하며 건강상태를 고려하여 담당의사와 충분한 상담 후 접종
- 9) RV1(로타바이러스 감염증): 생후 2, 4개월 2회 접종(경구투여)
- 10) RV5(로타바이러스 감염증): 생후 2, 4, 6개월 3회 접종(경구투여)
- 11) MMR(홍역·유행성이하선염·풍진): 홍역 유행 시 생후 6~11개월에 MMR 백신 접종이 가능하나 이 경우 생후 12개월(1세가 되는 생일) 이후에 MMR 백신으로 일정에 맞추어 접종
- 12) VAR(수두): 생후 12~15개월에 1회 접종
- 13) HepA(A형간염): 1차 접종은 생후 12~23개월에 시작하고 2차는 1차 접종으로부터 6개월 이상 경과한 후(제조사에 따라 추천 접종간격이 다름) 접종
- 14) IJEV(일본뇌염 불활성화 백신): 1차 접종 1개월 후 2차 접종을 실시하고, 추가 접종은 2차 접종으로부터 11개월 후, 6세, 12세에 접종
- 15) LJEV(일본뇌염 약독화 생백신): 1차 접종 12개월 후 2차 접종
- 16) HPV(사람유두종바이러스 감염증): 11~12세 여아에서 6~12개월 간격으로 2회 접종하고, 2가와 4가 백신 간 교차접종은 추천하지 않음

Ⅵ. 주요 변경사항

구 분	2024년 주요내용	2025년 주요 변경내용 및 사유	비고
세부 추진과제	(4쪽) - ① 학생 감염 감시 강화 및 예방 환경 조성 · ④ 방역을 고려한 학교 시설·환경 단계적 구축	→ 교육부에서 주관하는 학교시설 및 시스템 제도 개선 삭제	<삭제>
	(4쪽) - ③ 방역 인프라 확충 및 제도 개선 · ② 시스템 및 제도 개선		
1. 학생 감염 감시 강화 및 예방 환경 조성	(7쪽) - 1-1 감염병 감시 정보 공유 및 NEIS 체계 보완 · 가. 추진 현황 ○ (교육청) - 학교 내 감염병 발생 시 학교유행경보제 운영	(6쪽) - 1-1 감염병 감시 정보 공유 및 NEIS 체계 보완 · 가. 추진 현황 ○ (교육청) - 학교 내 감염병 발생 시 학교유행경보제 운영 검토 → 학교유행경보 발령이 학교 현장에 부담을 야기할 수 있으므로, 검토하여 운영	<수정>
	(8쪽) - 1-1 감염병 감시 정보 공유 및 NEIS 체계 보완 · 나. 주요 내용 학교 및 교육(지원)청별 대응반 구성	(6쪽) - 1-1 감염병 감시 정보 공유 및 NEIS 체계 보완 · 다. 주요 내용 ○ (교육청) 경남 학생 감염병 발생현황 주간별 분석 및 정보 제공 → 도내 학교 감염병 주간 발생 동향 안내에 따라 추가	<추가>
	(8쪽) - 1-1 감염병 감시 정보 공유 및 NEIS 체계 보완 · 나. 주요 내용 ○ 연 1회 이상 학생 감염병 관리 대응반 협의회 실시를 통한 보완 사항 점검 [학교]: 반기별 1회 이상 학교 감염병 발생 관련 협의회 실시	(7쪽) - 1-1 감염병 감시 정보 공유 및 NEIS 체계 보완 · 다. 주요 내용 ○ 감염병 관리 대응반 협의회를 통한 보완 사항 점검 [학교]: 감염병 확진자 다수 발생 또는 자체 판단에 따라 구성원간 감염병 관련 소통 → 보건교사 업무 경감 및 협의 목적(원활한 감염병 대응)에 따라 구성원간 소통으로 수정	<수정>

1. 학생 감염 감시 강화 및 예방 환경 조성	(8쪽) - 1-1 감염병 감시 정보 공유 및 NEIS 체계 보완 · 다. 평가 계획 ○ 세부과제: 학생 감염병 관리 대응 협의회 주체: 학교 및 교육(지원)청	(7쪽) - 1-1 감염병 감시 정보 공유 및 NEIS 체계 보완 · 라. 행정 사항 ○ 세부과제: 학생 감염병 관리 대응 협의회 제출대상: 교육(지원)청 → 주요 내용 변경에 따른 보고 제출대상 수정	<수정>
	(9쪽) - 1-2 학교 예방교육 및 홍보 강화 · 나. 주요 내용 ○ [교육청] 경남 학생 감 염병 발생현황 월별 분석 및 정보 제공 - 감염병 발생 현황 및 시기 별 빈발 감염병에 대하여 감염병별 유행 정보 안내	→ 1-1 감염병 감시 정보 공유 및 NEIS 체계 보완으로 이동 함에 따라 삭제	<삭제>
		(8쪽) - 1-2 학교 예방교육 및 홍보 강화 · 다. 주요 내용 ○ [학교] 학교 내 감염병 예방 강화를 위한 최소 교육 이수시간* (연간 4시간 이상) 마련 및 교육효과 제고를 위한 교육 방법 다양화 → 학생건강증진 시행계획 내용 추가	<추가>
	(9쪽) - 1-2 학교 예방교육 및 홍보 강화 · 다. 평가 계획 ○ 활동: 감염병 발생 현 황 및 홍보자료 배포 ○ 평가시기: 매년 12월	(9쪽) - 1-2 학교 예방교육 및 홍보 강화 · 라. 행정 사항 ○ 활동: 감염병 발생에 따 른 예방수칙 등 홍보자 료 배포 ○ 제출시기: 수시 → 감염병 발생에 따라 수시로 예방수칙 등 홍보자료 배포에 따라 활동 및 제출시기 수정	<수정>
	(12쪽) - 1-4 방역을 고려한 학교 시 설·환경 단계적 구축	→ 교육부에서 주관하는 학교 시 설·환경 단계적 구축 삭제	<삭제>

2. 학교 내 확산 시 대응체계 보완	(13쪽) - 2-1 학교 감염병 대응 역량 강화 · 나. 주요 내용 ○ [학교] 감염병 관리역량 강화를 위한 연수과정 운영 ○ [교육지원청] 학교 보건 교사 대상 모의훈련 등 연수시 전문가 초빙을 통한 의료역량 강화	(11쪽) - 2-1 학교 감염병 대응 역량 강화 · 다. 주요 내용 ○ [학교] 감염병 관리역량 강화를 위한 연수과정 운영 및 학교 자체 모의훈련 실시 ○ [교육지원청] 감염병 모의훈련시 다양한 구성원이 참여하는 연수를 실시하고, 감염병 전문가 초빙을 통한 의료역량 강화 → 학교 자체 모의훈련 실시 안내 및 교육지원청 모의훈련 연수시 보건교사 대상에서 다양한 구성원이 참여할 수 있도록 확대	<수정>
	(13쪽) - 2-1 학교 감염병 대응 역량 강화 · 나. 평가 계획 ○ 세부과제: 보건(담당)교사 대상 연수시 의료 전문성 향상을 위한 대응책 마련 ○ 활동: 보건(담당)교사 대상 연수시 의료인 등 전문성 향상 강의	(11쪽) - 2-1 학교 감염병 대응 역량 강화 · 라. 행정 사항 ○ 세부과제: 모의훈련 연수시 의료 전문성 향상을 위한 대응책 마련 ○ 활동: 관리자, 보건(담당)교사 대상 연수시 감염병 역량강화 위한 강의 → 주요 내용 변경에 따른 계획 수정	<수정>
		(11쪽) - 2-1 학교 감염병 대응 역량 강화 · 라. 행정 사항 ○ 세부과제: 전 교직원 감염병 관련 교육실시 ○ 활동: 중앙교육연수원에 탑재된 감염병 관련 연수 실시 ○ 내용: 전 교직원 이수율 ○ 제출대상: 교육(지원)청 직속 및 소속기관, 학교 ○ 평가시기: 매년 12월 → 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 개정에 따라 추가	<추가>

3. 방역 인프라 확충 및 제도 개선	(14쪽) - 3-2 시스템 및 제도 개선	→ 교육부에서 주관하는 시스템 및 제도 개선 삭제	<삭제>
추진 체계	(17쪽) - ○ 기획팀 - ○ 자문위원회	(14쪽) - ○ 기획팀 - ○ 감염병관리협의체 → 인사이드·위원변경에 따라 수 정 및 교육부 지침에 따라 자 문위원회를 감염병관리협의체 로 용어 수정	<수정>